

SH.GSR.01.ACT.03			رقم السياسة
تعريف المريض			عنوان السياسة
٢	رقم الإصدار	٢٠٢٦/٠٣/٠١	تاريخ إعداد
٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ اعتماد	٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ تفعيل
١٠	عدد الصفحات	٢٠٢٩/٠٤/٠١	تاريخ المراجعة
جميع الأقسام ب المستشفى			نطاق التفعيل
اعتماد	مراجعة	إعداد	
مدير المستشفى د/ وسام وهيبه	لجنة الجودة د/ ايمان سامي	مدير الشؤون العلاجية د/ محمد مختار رئيسة التمريض م/ هيام محمود فريق الجودة د/ باسل محمد - م/ ولاء سيد	



د/ ايمان سامي السيد
 مديرة الجودة
 مستشفى صيدناوي

السياسة

- يلتزم جميع العاملين بمستشفى صيدناوى باستخدام طريقتين لتعريف المرضى (اسم المريض رباعي الرقم الموحد) بجميع أقسام المستشفى.

الغرض

- التأكد من هوية المريض والتأكد من تقديم الخدمة الصحيحة للمريض الصحيح وذلك لتحقيق أمان المريض ومنع المخاطر التي قد يتعرض لها أثناء أي إجراء داخل المستشفى

التعريفات

- أساور التعريف: هي اساور جلد بها ورق صغير فارغ لكتابة بيانات المريض (الاسم الرباعي والرقم الموحد)
- الرقم الموحد: ويقصد به الرقم الموحد وهو رقم يعطى للمريض عند أول تعامل معه داخل المستشفى ولا يتغير أبدا عند أي تعامل مع المستشفى مرة أخرى ولا يمكن إعطاؤه لأي مريض آخر تحت أي ظرف.

إجراءات العمل

- ١) يتم تعريف المريض داخل المستشفى ب استخدام معرفين أساسيين وهما:
 - اسم المريض الرباعي (من بطاقة الرقم القومي)
 - الرقم الموحد (يتم استخراجه من صحيفة الدخول والخروج او اخطار الفحص الخاص ب المريض بعد تسجيل دخوله عبر سيستم الهيئة)

- التأكد من تعريف المريض:

- يقوم الفريق الطبي بالتأكد من تعريف المريض الواعي بسؤاله عن اسمه رباعي ومطابقته مع بيانات أسورة التعريف والملف الطبي (اسم المريض رباعي، الرقم الموحد).
- في حالة المرضى فاقدى الوعي أو الأهلية، يقوم المسؤول عن عمل إجراء مع المريض بالرجوع إلى أسورة التعريف والتحقق من صحة المعلومات بواسطة سؤال أهل المريض وأقاربه.

يتم التأكد من تعريف المريض على سبيل المثال وليس الحصر عند عمل الإجراءات التالية:

✓ عند دخول المريض

✓ عند أخذ عينة دم أو أي عينات أخرى لازمة للتحاليل الطبية والفحص المعمل (يتم وضع الملصق الخاص بالتعريف بعد أخذ العينة في محطة المريض).

✓ نقل دم ومشتقاته.

✓ أخذ عينة من سوائل جسم المريض.

✓ إعطاء الأدوية.

✓ التدخل الجراحي وأي إجراءات تداخلية.

✓ تحويل / نقل المريض.

✓ أشعة أو أي إجراءات تصويرية.

✓ عند التسليم والتسلم

✓ عند اخذ العلامات الحيوية

✓ عند تقييم المريض

✓ عند تركيب وفك الوصلات للمريض

✓ عند خروج المريض

✓ عند تسليم حاله وفاه

(٢) طريقة تعريف المريض:

❖ يتم استخدام اساور التعريف

- تقوم ممرضة الطوارئ بمجرد دخول المريض غرفة ملاحظة الطوارئ بوضع أسورة التعريف للمريض

- في حالة عدم توفر كمية أساور لكل المرضى يتم كتابة بيانات تعريف المريض على بلاستر يكتب عليه اسم المريض والرقم الموحد

- في حالة دخول المريض عن طريق مكتب الدخول إلى القسم الداخلي مباشرة يقوم موظف مكتب الدخول بوضع الأسورة للمريض

- توضع باليد اليمنى إلا إذا وجد سبب يمنع ذلك فتوضع باليد اليسرى (مثل حالات قسرة القلب) وإذا

تعذر ذلك توضع بالكاحل الأيمن يليه الكاحل الأيسر وفي حالة فشل كل ذلك يتم تعليق الأسورة في

ملابس المريض بدبوس الملابس الآمن أو كتابة بيانات المريض على بلاستر الكانيولا

- تقوم الممرضة بإعلام المريض وذويه بأهمية أسورة التعريف وأنه عند فقدانها يقوم بإبلاغ الممرضة فوراً وأنه لا يتم خلع أسورة التعريف إلا عندما تنتهي إجراءات الخروج كاملة.
- الممرضة مسئولة عن وضع أسورة جديدة إذا فقدت الأصلية أو أصبحت غير مقروءة
- عندما يُقدم إجراء علاجي للمريض ويستلزم خلع أسورة التعريف تقوم الممرضة بوضع أساور أخرى قبل خلع الأولى
- في حالة رفض المريض تركيب أسوره يتم عمل نموذج احداث غير متوقعه و توثيق رفض المريض داخل الملف في نموذج ملاحظات التمريض
- بعد موافقة الأهل يتم كتابة على ذراع المريض بقلم غير قابل للمسح (Permanent)
- ❖ المرضى المتشابهين في الاسم:
- يتم فصلهم في مكانين مختلفين بالقسم.
- تقوم مشرفة التمريض بإعلام العاملين بالقسم وكتابة "مريض متشابه" في نماذج التسليم والتسلم ISBAR
- تقوم مشرفة التمريض بكتابة (مريض متشابه في الاسم) على الملف الطبي وجميع مشتملاته.
- توزيع المرضى على فريق طبي مختلف (تمريض، أطباء)
- ❖ يتم تعريف جميع مشتملات المريض بالاسم الرباعي ورقم الملف الموحد وهي على سبيل المثال رسم القلب، رسم القلب بالمجهود، تقارير السونار، نتائج التحاليل، الجزء المستأصل من المريض في العمليات، الغذاء، كما يتم التعريف في كافة نماذج الملف الطبي نماذج الملف الطبي
- ❖ الاطفال حديثي الولادة داخل وحدة رعاية المبتسرين NCIU
- عند دخول الطفل حديثي الولادة إلى NICU تقوم ممرضة NICU بالتأكد من وجود ٢ أسورة اليد لكل طفل مثبتة على كاحل كلا من القدمين.
- تقوم الممرضة NICU بمراجعة بيانات أسورة الطفل مع الأم.
- تقوم ممرضة NICU بالتأكد من أن الأسورة محكمة حول كاحل الطفل لكيلا تقع وأيضاً لا تؤذي جلد الطفل.
- تقوم ممرضة NICU بوضع بصمة قدم الطفل في الملف الطبي للطفل.
- مراجعة سوار اليد:
- تقوم ممرضة NICU بمراجعة ٢ أسورة اليد لكل طفل مع الأم والأب قبل تثبيتهم على كاحل الطفل.
- يقوم طبيب NICU بمراجعة ٢ أسورة اليد لكل طفل كل يوم خلال الكشف الطبي.

❖ عناصر الرعاية المرتبطة بتعريف المريض

- الأدوية: يتم تعريف اسم المريض رباعي والرقم الموحد واسم الدواء والتاريخ وساعه التحضير والقائم بالتحضير الاسم ثنائي
- الدم ومشتقاته: يتم تعريف اسم المريض رباعي والرقم الموحد نوع الفصيلة وتاريخ التحضير والصلاحية
- الغذاء: يتم تعريف اسم المريض رباعي والرقم الموحد نوع الوجبة وتاريخ ووقت التحضير
- العينات: وضع ملصق باسم المريض رباعي والرقم الموحد بعد سحب العينة وقبل مغادرة المريض
- عينات الباثولوجي: وضع ملصق باسم المريض رباعي والرقم الموحد ومكان سحب الباثولوجي وتاريخ وساعة ما بعد سحب العينة مباشرة

٣) المعارف الممنوع استخدامها في تعريف المريض:

- رقم الغرفة
- رقم السرير
- اسم الطبيب
- اسم الممرضة
- اسم الشهرة

٤) حالات الخاصة التي لا يتبع فيها نفس عملية التعريف للمريض

❖ مرضي الغسيل الكلوي:

- يتم عمل كروت تعريفية تحتوي على اسم المريض رباعي والرقم الموحد وصورته وتقوم الممرضة بتسليمها للمريض بمجرد دخوله وحده الكلي واسترجاعه عند رحيل المريض وحفظه لحين عودته للمستشفى مرة أخرى

- في حالة تلف الكارت، تلتزم المستشفى بتوفير كارت جديد

❖ المرضى فاقد الهوية:

- المرضى الفاقدين الهوية كما في حالة (مرضى الإصابات المتعددة فاقد الوعي) يتم تعريفهم كمجهول (مجهول، "رقم مسلسل"، ورقم الملف الطبي).

❖ تعطل الخدمة بالسيستم (نظام تسجيل المرضى الخاص بالهيئة)

- يتم تعريف المريض ب الرقم التأميني، على ان يتم استخراج الرقم الموحد عند رجوع نظام الهيئة للعمل

❖ ولادة ام داخل المستشفى

- يقوم مكتب الدخول بمراجعة بطاقة الرقم القومي وإصدار صحيفة الدخول.

- تقوم الممرضة بتركيب أسورة التعريف للأم عليها البيانات الآتية:

■ الاسم الرباعي

■ الرقم الموحد

❖ حديثي الولادة

- بمجرد ولادة الطفل تقوم الممرضة بعمل ٢ أسورة يد لكل طفل تثبت على الكاحل لكلا القدمين ويقوم الطبيب بمراجعة ذلك وتكتب البيانات الآتية على الأسورة:
- ابن أو ابنة (اسم الأم).
- كتابة ارقام مسلسل (١ - ٢ - ٣):
- الرقم الموحد للأم.
- Triple / Twin (في حالة التوأم)
- وقت الولادة
- تاريخ الميلاد

- تقوم الممرضة بالعمليات أو كشك الولادة بوضع بصمة قدم الطفل في الملف الطبي للأم.
- تقوم الممرضة بالتأكد من أن الأسورة محكمة حول كاحل الطفل لكي لا تقع وأيضاً لا تؤذي جلد الطفل .

❖ دخول حديثي الولادة وحدة رعاية المبتسرين NICU:

- يقوم مكتب الدخول بمراجعة بطاقة الرقم القومي للأم وإصدار صحيفة الدخول للطفل.
- تقوم الممرضة بعمل ٢ أسورة يد لكل طفل تثبت على الكاحل لكلا القدمين ويقوم الطبيب بمراجعة ذلك وتكتب البيانات الآتية على الأسورة:
- ابن أو ابنة (اسم الأم).
- الرقم الموحد للطفل .
- Triple / Twin (في حالة التوأم)
- كتابة ارقام مسلسل (١ - ٢ - ٣):
- تاريخ الميلاد
- وقت الولادة

- يتم استخدام الرقم الموحد للطفل والذي يحتوي على كود مرجعي للمستشفى (OH0008) في نهايته في حالة عدم استخراج رقم قومي للطفل (عدم استخراج شهادة ميلاد)

❖ في حالة دخول الطفل NICU بعد الولادة بالملاحظة (السيرفو)

- يقوم مكتب الدخول بمراجعة بطاقة الرقم القومي للأم وإصدار إخطار فحص للطفل بها اسم و رقم

موحد

❖ الكوارث والحوادث

- يعامل أي مريض ليس معه بطاقة هوية معاملة المريض فاقد الهوية (مجهول)

❖ إضافة معرف للمريض لعملية خاصة بأحد الأقسام

- يسمح بإضافة معرف إضافي للمريض عند الحاجة لتعريفه قبل إجراء معين أو إذا كان مطلوباً في

نموذج أو طلب أو وثيقة رسمية ذلك شريطة استيفاء ٣ شروط أساسية:

- أولاً: يجب على صاحب العملية أو رئيس القسم إبلاغ قسم الجودة
- ثانياً: عدم استخدام المعرفات الممنوعة المذكورة في السياسة (رقم ٣ في إجراءات العمل)
- ثالثاً: الالتزام التام بالمعرفين الأساسيين المذكورين في السياسة (اسم المريض الرباعي، الرقم الموحد)

٥) أخطاء اثناء عملية تعريف المريض

❖ في حالة وجود خطأ في عملية التعرف على المريض يتم كتابة نموذج تقرير واقعة طبقاً لسياسة رفع تقرير عن واقعة.

❖ عند فقد أسورة تعريف طفل حديث الولادة

- في حالة فقد أسورة يد واحدة: تقوم ممرضة NICU بتركيب أسورة يد جديدة.
- في حالة فقد ٢ أسورة يد لطفل واحد في القسم:
- تقوم ممرضة NICU بإبلاغ مشرفة الوحدة.
- تقوم ممرضة NICU بمراجعة أساور اليد لكل الأطفال حديثي الولادة في الوحدة.
- يقوم الطبيب المختص بمراجعة الحالة ويقر بصحة بيانات الطفل.
- تقوم ممرضة NICU بعمل عدد (٢) أسورة يد جديدة وعليها بيانات الطفل بعد مراجعتها مع الأم والطبيب المختص.
- تقوم ممرضة NICU بكتابة تقرير أحداث غير متوقعة.
- في حالة فقد ٢ أسورة يد لأكثر من طفل في القسم:
- تقوم ممرضة NICU بإبلاغ مشرفة القسم ومديرة التمريض ومدير المستشفى.
- تقوم ممرضة NICU بكتابة تقرير أحداث غير متوقعة.
- يتم استخدام تقنية DNA لمعرفة نسب الأطفال الغير معروفين.

يتم تدريب جميع الموظفين ومقدمي الرعاية الصحية (الجدد والحاليين) الذين لهم صلة بالتعامل مع المرضى على هذه السياسة وإجراءاتها

المسؤول عن التنفيذ

- موظفي الاستقبال ومكتب الدخول
- كافة افراد الفريق الطبي
- فريق الجودة: مراقبة والتقييم والتحسين

المراقبة والتقييم

- KPI: يتم عمل كارت لمؤشر له علاقة بعملية مرتبطة بالسياسة مع متابعة تحقيق الهدف المراد و نسبته الناتجة من قيمة المؤشر عند القياس لضمان التحسين المستمر
- تقوم المستشفى بتتبع وجمع وتحليل وعمل تقرير عن البيانات المتعلقة بعملية تعريف المريض. تعمل المستشفى على فرص التحسين المحددة في عملية تعريف المريض.

النماذج / المرفقات

- كافة نماذج الملف الطبي
- السجلات الخاصة بالأقسام
- صحيفة الدخول والخروج
- نموذج احداث غير متوقعة

معايير ذات صلة

ACT.14 Patient's referral, transfer, temporary discharge, and discharge, DAS.04 Pre-examination process, DAS.08 Medical imaging results , DAS.15 Specimen reception, tracking and storage, ICD.20 Ordering of blood and blood products, MMS.13 medication preparation area, labeling of medications, IMT. 08 Patient's Medical record Management.

المراجع

دليل معايير اعتماد المستشفيات -الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، إصدار ٢٠٢٥. (معييار ACT.03).

نموذج الأحداث غير المتوقعة



الهيئة العامة للتأمين الصحي
فرع :
مستشفى :

OCCURRENCE VARIANCE REPORT (OVR)

(.....) OVR Code No.

THIS FORM SHOULD BE FORWARDED TO THE QUALITY DEPARTMENT WITHIN 72 HOURS

يجب أن يسلم النموذج لقسم الجودة في خلال 72 ساعة

Reported by Name (OPTIONAL): اسم المبلغ (اختياري)		Department: القسم	
Reported by Signature: توقيع المبلغ		Date of Reporting: تاريخ التبليغ	

INDIVIDUAL OR MEMBER OF STAFF INVOLVED (Tick One or More)

☐ Nurse ممرضة	☐ Physician طبيب	☐ Administrative إداري	☐ Patient مريض
☐ Nursing Aid مساعد ممرضة	☐ Technician فني	☐ Security فرد أمن	☐ Other أخرى

OCCURRENCE INFORMATION

Date of Incident تاريخ الحادث	Time of Incident وقت وقوع الحادث	Location/Unit الوحدة/المكان
Name of Person Involved اسم الشخص المعني	Patient I.D. رقم الملف الطبي	☐ Female أنثى ☐ Male ذكر

Briefly describe the incident/ occurrence and attach the supporting data when applicable
وصف ملخص للحادث مع الدعم بمستند إذا أمكن

Immediate Corrective Action taken: To be completed by involved/concerned department
الإجراء التصحيحي المتخذ : يتم كتابته من قبل الشخص المسئول

Suggested Preventive Action: To be completed by the concerned Head of Department for follow up
الإجراء التصحيحي المقترح : يتم كتابته من قبل رئيس القسم المختص

Name:..... Date:..... Time:..... Signature:.....

O.V.R. 1-2

الهيئة العامة للتأمين الصحي
فرع :
مستشفى :

يتم كتابته بواسطة الجودة

CLASSIFICATION OF OCCURRENCE VARIANCE:		
PATIENT CARE ISSUES	SENTINEL EVENT	MEDICATION ERROR
☐ Complication following procedure	☐ Unanticipated death not related to the natural cause of illness	Medication's Name: _____
☐ Procedure delay	☐ Major permanent loss of function	☐ Wrong Drug Wrong Dose
☐ Patient care delay	☐ Wrong-site of surgery	☐ Wrong Time Wrong Route
☐ Use of Blood/Blood Products e.g. Blood Reaction	☐ Wrong-procedure / surgery	☐ Wrong Patient Missed Dose
☐ Pressure ulcer Community : Hospital	☐ Wrong-patient surgery	☐ Drug not given I.V.infiltration
☐ Others, Specify:	☐ Others, Specify:	☐ Expired Drug
☐ Delay in order to pharmacy		☐ Delay in order to pharmacy
☐ Others, Specify:	☐ Others, Specify:	☐ Others, Specify:
IPSGS	COMMUNICATION	DOCUMENTATION OR RECORDS
☐ Patient Identification	☐ Property loss – : Staff : Patient	☐ Health record unavailable or delayed
☐ Fall or Found on Floor	☐ Behavioral – : Staff : Patient	☐ Illegible entry or order
☐ Transfer/ Handover Communication	☐ Ethical	☐ Incomplete or inaccurate documentation
☐ Safe Surgery	☐ Patient Complaint	
☐ Reduce Risk of Infection (hand- hygiene guidelines)		
☐ Others, Specify:	☐ Others, Specify:	☐ Others, Specify:
FMS	EQUIPMENT	PCI
☐ Fire Alarm : Theft	☐ Equipment use related	☐ Sharps /Needle Stick Injury
☐ Smoking Environmental		
☐ Breakdown of doors		☐ Isolation Violation
☐ Safety and Security		
☐ Others, Specify:	☐ Others, Specify:	☐ Others, Specify:
Others not classified above, Specify:		
☐ This Event is considered: ☐ Sentinel ☐ Adverse ☐ Near Miss ☐ Risk Score / Degree of Harm/Injury: () نتيجة تقييم خطورة الحدث QUALITY DEPARTMENT RECOMMENDATION توصية إدارة الجودة		
Quality Manager Signature : _____ Date: _____ Time : _____		
Follow-up Status of action taken: متابعة حالة الإجراء المتخذ ☐ Appropriate & complete كامل ومناسب ☐ Inappropriate & incomplete كامل وغير مناسب ☐ No further action required ليس هناك إجراء مطلوب ☐ Other أخرى		

O . V . R . 2-2

[illegible][illegible]